

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

**Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.**

NOTA PEMBELAJARAN

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	P851-002-4:2025 PRESCHOOL TEACHING		
TAHAP / LEVEL	4		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	P851-002-4:2025-C01 / CONDUCT DAILY ROUTINE ACTIVITIES		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	P851-002-4:2025-C01-W01 / Handle pupil's arrival P851-002-4:2025-C01-W02 / Handle pupil's recess time P851-002-4:2025-C01-W03 / Handle pupil's toilet break P851-002-4:2025-C01-W04 / Handle pupil's dismissal		
NO. KOD / CODE NO.	P851-002-4:2025-C01/NP(1/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 4

PROSES KERJA BERKAITAN:

P01

JAM PENGETAHUAN:

42.0 j (168 j x 25% pemberat WA)

TAJUK:

Mengendalikan Ketibaan Kanak-Kanak di Prasekolah (Handling Pupil's Arrival)

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 2/31
---------	-----------------------------	-----------------

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses mengendalikan ketibaan kanak-kanak ke prasekolah dengan selamat dan teratur, merangkumi lapan bab yang saling berkait: Bab 1 — Introduction to pupil safety and security (keselamatan premis dan asas teori tingkah laku selamat), Bab 2 — Elements of cleaning activities (kebersihan sebagai garis pertahanan pertama terhadap jangkitan), Bab 3 — Workstation criteria (reka bentuk stesen pemeriksaan fizikal), Bab 4 — Welcoming pupils and parents/guardian (komunikasi dan sambutan emosi), Bab 5 — Basic health screening procedures (saringan kesihatan mengikut dasar badan kawal selia), Bab 6 — Types of record procedure (kaedah merekod dan kerahsiaan), Bab 7 — Pupil health condition (pengecaman tanda tidak sihat) dan Bab 8 — Pupil's handover (serah tugas kepada guru kelas). Kelapanlapan bab ini penting kerana ketibaan adalah titik kawalan pertama bagi keselamatan dan kesihatan kanak-kanak sepanjang hari persekolahan — sebarang kelemahan pada mana-mana satu bab (contohnya stesen yang tidak teratur atau rekod yang tidak lengkap) boleh mencatatkan keseluruhan rantaian kawalan, selaras tuntutan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang meletakkan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak sebagai keutamaan tertinggi sebelum sebarang aktiviti pembelajaran bermula. Nota ini juga disediakan sebagai bahan rujukan lengkap yang boleh dicetak dan digunakan sebagai panduan operasi harian tadika, bukan sekadar bahan peperiksaan.

Kandungan nota ini:

- Bab 1: Introduction to pupil safety and security
- Bab 2: Elements of cleaning activities
- Bab 3: Workstation criteria
- Bab 4: Welcoming pupils and parents/guardian
- Bab 5: Basic health screening procedures
- Bab 6: Types of record procedure
- Bab 7: Pupil health condition
- Bab 8: Pupil's handover

PENERANGAN:

Bab 1: Introduction to pupil safety and security

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep teori pembelajaran sosial (social learning theory) dalam konteks keselamatan kanak-kanak prasekolah.
- Menyenaraikan kandungan SOP Indoor, SOP Outdoor dan SOP Arrival.
- Mengenal pasti risiko keselamatan biasa di kawasan dalam dan luar bangunan prasekolah.
- Mengaitkan tanggungjawab guru dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996 dan Garis Panduan Penubuhan Tadika Swasta KPM.

1. Definisi dan Konsep Asas

Keselamatan dan keteguhan (*safety and security*) dalam konteks prasekolah merujuk kepada keadaan bebas daripada bahaya fizikal (kecederaan, jatuh, tersepit, terhiris) dan bebas daripada ancaman luar (orang tidak dikenali memasuki premis, kanak-kanak tersesat atau diambil oleh individu tidak dibenarkan). Akta Pendidikan 1996 tidak secara langsung mengawal selia tadika swasta (yang berada di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 dan pendaftaran JKM/KPM bagi komponen prasekolah), tetapi semangat perundangan mengenai tanggungjawab institusi pendidikan terhadap kebajikan pelajar tetap terpakai sebagai asas etika profesion keguruan. KSPK 2017 (Semakan) meletakkan domain "Keselamatan dan Kesejahteraan" sebagai salah satu tunjang yang mesti dipastikan sebelum mana-mana domain pembelajaran lain (bahasa, kognitif, sosioemosi) boleh berlaku secara berkesan — kanak-kanak yang berasa tidak selamat secara fisiologi dan psikologi tidak berada dalam keadaan bersedia untuk belajar.

2. Teori Pembelajaran Sosial dalam Keselamatan Kanak-Kanak

Social learning theory (Albert Bandura) menerangkan bahawa kanak-kanak belajar tingkah laku selamat melalui pemerhatian dan peniruan (modelling) terhadap guru dan rakan sebaya. Guru prasekolah yang sentiasa menunjukkan tingkah laku berhati-hati — seperti memeriksa kawasan permainan sebelum digunakan, berjalan (bukan berlari) di lorong, dan memegang pagar semasa menuruni tangga — secara tidak langsung membentuk kebiasaan selamat dalam diri kanak-kanak. Sarjana lain seperti Urie Bronfenbrenner turut menekankan bahawa persekitaran mikrosistem (kelas, rumah) membentuk tingkah laku kanak-kanak secara berterusan, justeru konsistensi amalan keselamatan guru amat penting. Dalam praktik harian, ini bermakna guru tidak boleh "bercakap satu perkara, buat perkara lain" — contohnya melarang kanak-kanak berlari di koridor sambil guru sendiri tergesa-gesa berlari semasa waktu ketibaan.

3. Prosedur Langkah demi Langkah — Pemeriksaan Premis Sebelum Ketibaan

Guru bertugas awal (rota mingguan) tiba sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu ketibaan rasmi.

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 4/8
---------	-----------------------------	----------------

Buka semua pintu kecemasan dan pastikan tiada halangan pada laluan keluar.

Jalankan pemeriksaan SOP Indoor mengikut senarai semak (lihat Jadual 1).

Jalankan pemeriksaan SOP Outdoor mengikut senarai semak (lihat Jadual 1).

Sediakan zon *drop-off* dan pastikan tanda arah kenderaan jelas kelihatan.

Aktifkan sistem pengawasan (CCTV/pengawal keselamatan/guru bertugas pintu) di titik masuk utama.

Tandatangan borang pemeriksaan premis harian dan serahkan kepada pengetua/penyelia sebelum pintu dibuka kepada ibu bapa.

Sebarang kerosakan yang ditemui direkod dalam buku aduan penyelenggaraan dan dilaporkan segera — kawasan berkenaan ditutup sementara sehingga dibaiki.

4. SOP Indoor

Merangkumi pemeriksaan lantai licin, susunan perabot tanpa sudut tajam terdedah, soket elektrik berpenutup, pintu kecemasan tidak berhalang, tangga bertutup pagar keselamatan, dan alat pemadam api dalam tempoh sah laku. Semakan dilakukan setiap pagi sebelum pintu prasekolah dibuka kepada ibu bapa.

5. SOP Outdoor

Merangkumi pemeriksaan pagar keselamatan tertutup rapat dan berkunci, peralatan permainan luar (gelongsor, buaian, jungle gym) tiada kerosakan/karat/skru longgar, kawasan berumput bebas dari objek berbahaya (kaca, batu tajam), takungan air disalurkan, dan pengawasan pintu masuk/keluar utama oleh petugas keselamatan atau guru bertugas.

6. SOP Arrival

Menetapkan lokasi turun kenderaan (drop-off zone) yang berasingan daripada laluan pejalan kaki, laluan berjalan yang selamat dari kawasan letak kereta ke pintu masuk dengan pengiring dewasa, serta had masa ketibaan mengikut jadual sekolah supaya pengawasan tidak terlalu meluas serentak.

Jadual 1 — Senarai Semak Pemeriksaan Premis Harian			
Kawasan	Item Diperiksa	Status (✓ / X)	Catatan
Indoor — Lantai	Tidak licin, kering		
Indoor — Perabot	Tiada sudut tajam terdedah		
Indoor — Elektrik	Soket berpenutup		
Indoor — Kecemasan	Pintu tidak berhalang		

Indoor — Tangga	Pagar keselamatan terpasang		
Indoor — Pemadam Api	Tempoh sah laku belum tamat		
Outdoor — Pagar	Tertutup rapat dan berkunci		
Outdoor — Peralatan Bermain	Tiada karat/skru longgar		
Outdoor — Kawasan Rumput	Bebas objek berbahaya		
Outdoor — Takungan Air	Disalurkan		
Arrival — Zon Drop-off	Berasingan dari laluan pejalan kaki		
Arrival — Pengawasan	Petugas/guru di pintu masuk utama		

Jadual 2 — Perbandingan SOP Indoor vs SOP Outdoor vs SOP Arrival

Aspek	SOP Indoor	SOP Outdoor	SOP Arrival
Fokus utama	Keselamatan struktur dalaman	Keselamatan peralatan luar	Aliran dan kawalan masuk
Masa semakan	Sebelum pintu dibuka	Sebelum pintu dibuka	Sepanjang tempoh ketibaan
Risiko utama	Kejatuhan, kecederaan elektrik	Kerosakan peralatan, objek tajam	Kanak-kanak tercicir/hilang
Penanggungjawab	Guru bertugas dalaman	Guru bertugas luar/penyelia	Guru pintu/pengawal

Kajian Kes Tadika 1 — Tadika Ceria, 25 murid, 2 guru

Tadika Ceria beroperasi dengan dua orang guru sahaja pada waktu ketibaan. Pada suatu pagi, salah seorang guru sibuk menyambut ibu bapa sementara guru kedua sepatutnya menyemak SOP Outdoor tetapi terlepas pandang kerana kesuntukan masa. Seorang kanak-kanak hampir tersandung skru longgar pada gelongsor. Selepas insiden ini, Tadika Ceria menetapkan bahawa pemeriksaan SOP Outdoor mesti selesai dan ditandatangani SEBELUM mana-mana guru dibenarkan menyambut ibu bapa, tanpa pengecualian, walaupun ini bermakna pintu dibuka lima minit lewat.

Kajian Kes Tadika 2 — Tadika Bestari, 40 murid, 4 guru

Tadika Bestari mengagihkan tugas mengikut rota mingguan: seorang guru khusus untuk SOP Indoor, seorang untuk SOP Outdoor, dan dua guru untuk zon *arrival*. Sistem ini mengurangkan kekeliruan "siapa buat apa" dan memastikan tiada kawasan tertinggal semakan, walaupun apabila seorang guru bercuti menjejut.

5. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

- Kesilapan:* Pemeriksaan dilakukan secara tergesa-gesa tanpa senarai semak bertulis.
- *Cara mengelak:* Gunakan Jadual 1 sebagai dokumen wajib, bukan hafalan.

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 6/31
---------	-----------------------------	-----------------

• Kesilapan:* Guru menandatangani borang tanpa benar-benar memeriksa (rubber-stamping). *Cara mengelak:* Penyelia menjalankan semakan rawak (*spot check*) sekali seminggu.

• Kesilapan:* Zon *drop-off* bertindih dengan laluan pejalan kaki semasa waktu puncak. *Cara mengelak:* Tanda jalan yang jelas dan guru pengawal berdiri di titik silang.

6. Senarai Semak Ringkas (Sedia Difotokopi)

- ☐ Semua pintu kecemasan tidak berhalang
- ☐ SOP Indoor selesai dan ditandatangani
- ☐ SOP Outdoor selesai dan ditandatangani
- ☐ Zon drop-off jelas dan bebas laluan pejalan kaki
- ☐ Guru pengawas berada di pintu masuk utama sebelum 15 minit dari waktu ketibaan

7. Aktiviti Pengukuhan

- Bakat menjalankan simulasi pemeriksaan SOP Indoor dan Outdoor menggunakan Jadual 1 di kawasan sebenar (atau gambar rajah) dan membentangkan dapatan.
- Bakat mengenal pasti satu risiko tersembunyi (*hidden hazard*) di sebuah gambar kawasan prasekolah dan mencadangkan tindakan pembetulan.
- Bakat menulis satu senario ringkas di mana seorang guru menunjukkan tingkah laku selamat yang boleh ditiru kanak-kanak (aplikasi social learning theory).

8. Rumusan

Keselamatan dan keteguhan premis dalam dan luar mesti disahkan setiap pagi sebelum kanak-kanak tiba, berpandukan SOP masing-masing dan prinsip pembelajaran sosial yang menjadikan guru sebagai model tingkah laku selamat sepanjang masa, bukan hanya semasa waktu ketibaan. Prosedur langkah demi langkah, senarai semak bertulis, dan pengagihan tugas yang jelas (seperti diamalkan oleh Tadika Bestari) mengurangkan risiko insiden akibat kecuai atau kesuntukan masa.

Bab 2: Elements of cleaning activities

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan item dalam checklist pembersihan kawasan prasekolah.
- Menjelaskan kaedah dan alat pembersihan yang sesuai bagi setiap kawasan.
- Menyediakan jadual pembersihan harian/mingguan.
- Membezakan bahan pembersih yang selamat digunakan berhampiran kanak-kanak.

1. Definisi dan Konsep Asas

Aktiviti pembersihan (*cleaning activities*) dalam konteks prasekolah bukan sekadar estetika tetapi merupakan komponen kawalan jangkitan (*infection control*) yang kritikal, kerana kanak-kanak prasekolah mempunyai sistem imun yang belum matang sepenuhnya dan tabiat menyentuh mulut/hidung/mata dengan tangan yang kerap. Garis panduan kebersihan KKM bagi pusat jagaan kanak-kanak menekankan pembersihan permukaan yang kerap disentuh (*high-touch surfaces*) sebagai keutamaan, kerana permukaan seperti pemegang pintu, meja, dan mainan bersama adalah titik pemindahan kuman yang paling kerap dalam persekitaran kanak-kanak.

2. Checklist Cleaning Area

Senarai semak meliputi kawasan kelas, tandas, ruang makan, kawasan permainan luar, dan pintu masuk — setiap item ditanda selesai sebelum kanak-kanak tiba. Checklist biasanya ditandatangani oleh guru bertugas dan disimpan sebagai rekod kepatuhan SOP tadika.

3. Cleaning Method dan Cleaning Tools

Kaedah termasuk menyapu, mengelap dengan bahan pembersih berkesan disinfeksi (mengikut garis panduan MoH), penyemburan disinfektan pada mainan yang kerap disentuh, dan pengudaraan bilik sebelum kanak-kanak masuk. Alat termasuk penyapu, kain lap warna berasingan mengikut kawasan (elak silang cemar antara tandas dan ruang makan), berus tandas, dan sabun/disinfektan bertanda selamat kanak-kanak (bebas bahan toksik kuat).

4. Prosedur Langkah demi Langkah — Rutin Pembersihan Pagi

Guru bertugas mencapai kelas 45 minit sebelum ketibaan pertama.

Buka semua tingkap untuk pengudaraan sekurang-kurangnya 10 minit.

Sapu dan lap lantai bermula dari sudut terjauh ke arah pintu.

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 8/31
---------	-----------------------------	-----------------

Semburkan disinfektan pada semua permukaan kerap disentuh (meja, kerusi, pemegang pintu, suis lampu).

Lap kering permukaan selepas tempoh sentuh disinfektan (*contact time*) mengikut label produk.

Semak dan bersihkan mainan yang digunakan pada sesi sebelumnya (bukan sekadar mainan yang kelihatan kotor).

Bersihkan tandas mengikut giliran (sebelum waktu puncak).

Tandatangan checklist pembersihan dan letakkan di papan kenyataan kelas.

Jadual 3 — Cleaning Schedule

Kawasan	Kekerapan
Kelas dan alat permainan	Setiap hari, sebelum dan selepas sesi
Tandas	Sebelum dan selepas waktu puncak
Kawasan luar	Setiap pagi sebelum ketibaan
Mainan digunakan bersama	Selepas setiap sesi bermain

Jadual 4 — Kod Warna Kain Lap (Colour-Coded Cleaning System)

Warna	Kawasan Ditetapkan	Sebab Pengasingan
Merah	Tandas	Risiko jangkitan tertinggi
Biru	Permukaan meja/kerusi	Kawasan makan dan belajar
Kuning	Dapur/ruang penyediaan makanan	Kebersihan makanan
Hijau	Mainan dan alat pembelajaran	Sentuhan tangan kanak-kanak paling kerap

Kajian Kes Tadika 1 — Tadika Ceria, 25 murid, 2 guru

Tadika Ceria pada mulanya menggunakan satu jenis kain lap untuk semua kawasan bagi menjimatkan kos. Selepas seorang kanak-kanak mengalami cirit-birit berjangkit yang merebak kepada tiga kanak-kanak lain dalam tempoh seminggu, pihak pengurusan menyiasat dan mendapati kain lap tandas turut digunakan untuk mengelap meja makan. Sistem kod warna (Jadual 4) kemudiannya diperkenalkan dan kes jangkitan silang berkurangan secara ketara pada penggal berikutnya.

Kajian Kes Tadika 2 — Tadika Bestari, 40 murid, 4 guru

Tadika Bestari melantik seorang pembantu am khusus untuk memantau checklist pembersihan setiap pagi, berasingan daripada guru kelas. Ini membebaskan guru untuk fokus kepada penyediaan pengajaran sambil memastikan kebersihan tidak terabai akibat beban tugas guru yang bertindih.

5. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 9/31
---------	-----------------------------	-----------------

• Kesilapan:* Menyembur disinfektan dan terus mengelap kering serta-merta tanpa memberi tempoh sentuh (*contact time*) yang mencukupi, menyebabkan disinfeksi tidak berkesan. *Cara mengelap:* Rujuk label produk dan tunggu tempoh yang disyorkan (biasanya 1–10 minit).

• Kesilapan:* Menggunakan kain lap yang sama merentasi kawasan berbeza. *Cara mengelap:* Kuatkuasa sistem kod warna dan latih semua kakitangan (termasuk pembantu sambilan).

• Kesilapan:* Bahan pembersih pekat disimpan di paras yang boleh dicapai kanak-kanak. *Cara mengelap:* Simpan semua bahan kimia di almari berkunci di luar capaian kanak-kanak.

6. Senarai Semak Ringkas (Sedia Difotokopi)

- ☐ Kelas disapu, dilap dan diudarakan sebelum ketibaan
- ☐ Semua permukaan kerap disentuh didisinfeksi
- ☐ Mainan sesi terdahulu dibersihkan
- ☐ Tandas dibersihkan sebelum waktu puncak
- ☐ Kain lap digunakan mengikut kod warna yang betul
- ☐ Bahan kimia disimpan berkunci, jauh dari capaian kanak-kanak

7. Aktiviti Pengukuhan

- Bakat menyediakan jadual pembersihan mingguan lengkap untuk sebuah kelas contoh dengan 20 murid.
- Bakat mengenal pasti tiga bahan pembersih yang TIDAK sesuai digunakan berhampiran kanak-kanak dan menerangkan sebabnya.
- Bakat mereka bentuk poster kod warna kain lap untuk dipamerkan di stor pembersihan.

8. Rumusan

Checklist, kaedah, alat dan jadual pembersihan yang konsisten serta bahan pembersih selamat memastikan prasekolah sentiasa bersih dan selamat sebelum sesi bermula setiap hari, sekali gus mengurangkan risiko penyakit berjangkit dalam kalangan kanak-kanak. Sistem kod warna dan pengasingan tugas pembersihan — seperti yang diamalkan Tadika Ceria dan Tadika Bestari selepas pengalaman sebenar — adalah pelaburan kecil yang memberi kesan besar terhadap kesihatan kelas secara keseluruhan.

Bab 3: Workstation criteria

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menerangkan reka letak (layout) stesen pemeriksaan fizikal yang sesuai.
- Menyenaraikan alat yang perlu disediakan di stesen tersebut.
- Menyediakan kawasan pintu masuk yang teratur untuk pemeriksaan.
- Menilai keperluan ruang bagi mengelakkan kesesakan semasa waktu puncak.

1. Definisi dan Konsep Asas

Workstation* dalam konteks ketibaan prasekolah merujuk kepada titik fizikal tetap di mana saringan kesihatan asas dijalankan ke atas setiap kanak-kanak sebelum dibenarkan masuk ke kawasan kelas. Kriteria reka bentuk stesen ini bukan sekadar soal kemudahan operasi tetapi turut merupakan aplikasi prinsip *ergonomics for young children* — peralatan dan susun atur mesti disesuaikan dengan tinggi dan tahap keselesaan psikologi kanak-kanak, bukan orang dewasa, supaya proses saringan tidak menimbulkan trauma atau ketakutan pada usia awal.

2. Layout

Stesen diletakkan berhampiran pintu masuk utama, membolehkan pemeriksaan dilakukan sebelum kanak-kanak masuk ke kawasan kelas, dengan ruang menunggu bergaris jarak selamat. Susun atur perlu membenarkan seorang kanak-kanak diperiksa pada satu masa tanpa menghalang laluan kanak-kanak lain yang belum diperiksa.

3. Tools

Termometer inframerah (tanpa sentuh), hand sanitizer, buku log/borang digital, sarung tangan pelupusan bagi guru yang menjalankan pemeriksaan, dan meja/kaunter kecil setinggi paras kanak-kanak supaya proses tidak menakutkan.

4. Prosedur Langkah demi Langkah — Menyediakan Stesen Sebelum Waktu Puncak

Pasang meja/kaunter di lokasi tetap berhampiran pintu masuk, tidak menghalang laluan kecemasan.

Letakkan termometer inframerah yang telah dikalibrasi/diuji baterinya pagi itu.

Sediakan hand sanitizer pada paras capaian kanak-kanak dan capaian dewasa.

Letakkan buku log/tablet digital dan pen sedia digunakan.

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka surat 11/31
----------------	-----------------------------	------------------

Sediakan sarung tangan pelupusan yang mencukupi untuk seluruh tempoh ketibaan.

Tanda lantai (jejak kaki/garisan) bagi menunjukkan jarak menunggu satu meter.

Guru bertugas memakai sarung tangan dan bersedia di stesen sebelum pintu dibuka.

Semak semula kelengkapan stesen setiap 30 minit sepanjang waktu ketibaan (baki hand sanitizer, bateri termometer).

5. Entrance Area

Kawasan masuk perlu jelas ditanda, satu hala aliran (one-way flow) untuk elak kesesakan, dan dilengkapi tanda visual mesra kanak-kanak (contoh: jejak kaki bergambar pada lantai untuk menunjukkan arah barisan).

Jadual 5 — Senarai Semak Kelengkapan Stesen

Item	Ada (✓ / X)	Kuantiti Disyorkan	Catatan
Termometer inframerah		1–2 unit	Bateri disemak setiap pagi
Hand sanitizer		1 botol besar	Isi semula sepanjang hari
Buku log / borang digital		1 set	Backup kertas jika digital rosak
Sarung tangan pelupusan		Secukupnya untuk sehari	Tukar setiap 1–2 jam
Meja/kaunter setinggi kanak-kanak		1 unit	Elak permukaan tajam
Tanda arah/jejak kaki		Sepanjang laluan	Warna cerah, mesra kanak-kanak

Jadual 6 — Perbandingan Reka Bentuk Stesen Mengikut Saiz Tadika

Kriteria	Tadika Kecil (<30 murid)	Tadika Besar (>60 murid)
Bilangan stesen	1 stesen mencukupi	2–3 stesen selari disyorkan
Bilangan guru bertugas	1 guru	2–3 guru serentak
Anggaran masa per kanak-kanak	1–2 minit	Perlu dikurangkan ke <1 minit/stesen
Risiko kesesakan	Rendah	Tinggi jika hanya 1 stesen

Kajian Kes Tadika 1 — Tadika Ceria, 25 murid, 2 guru

Dengan hanya 25 murid, Tadika Ceria mendapati satu stesen tunggal mencukupi asalkan proses saringan tidak melebihi dua minit seorang. Guru menetapkan had masa dengan menggunakan jam pasir kecil yang turut menarik minat kanak-kanak, menjadikan proses saringan seperti "permainan" dan bukan sesuatu yang menakutkan.

Kajian Kes Tadika 2 — Tadika Bestari, 40 murid, 4 guru

Tadika Bestari, dengan bilangan murid lebih ramai, mendapati satu stesen menyebabkan

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka surat 12/31
---------	-----------------------------	------------------

Kriteria	Tadika Kecil (<30 murid)	Tadika Besar (>60 murid)
barisan panjang dan kanak-kanak resah menunggu. Selepas menambah stesen kedua yang beroperasi serentak pada waktu puncak (7.30–8.00 pagi), masa menunggu purata berkurangan dan kanak-kanak kelihatan lebih tenang semasa saringan.		

6. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

- Kesilapan:* Stesen diletakkan terlalu jauh dari pintu masuk, menyebabkan kanak-kanak "terlepas" saringan kerana terus masuk ke kelas. *Cara mengelak:* Stesen mesti berada tepat pada laluan wajib sebelum kelas, bukan pilihan.
- Kesilapan:* Meja terlalu tinggi menyebabkan kanak-kanak kecil takut atau tidak selesa. *Cara mengelak:* Gunakan kaunter/meja setinggi paras dada kanak-kanak atau guru berlutut semasa memeriksa.
- Kesilapan:* Sarung tangan tidak ditukar antara kanak-kanak yang menunjukkan tanda tidak sihat. *Cara mengelak:* Sediakan bekas sarung tangan mencukupi dan tukar selepas setiap kes disyaki.

7. Senarai Semak Ringkas (Sedia Difotokopi)

- ☐ Stesen berada di laluan wajib berhampiran pintu masuk
- ☐ Termometer berfungsi dan dikalibrasi
- ☐ Hand sanitizer dan sarung tangan mencukupi
- ☐ Buku log/borang digital sedia digunakan
- ☐ Tanda arah/jejak kaki jelas kelihatan
- ☐ Jarak menunggu selamat ditanda pada lantai

8. Aktiviti Pengukuhan

- Bakat melukis pelan lantai stesen pemeriksaan yang sesuai untuk tadika 40 murid, termasuk laluan masuk dan keluar.
- Bakat menyenaraikan lima kelengkapan tambahan yang boleh meningkatkan keselesaan kanak-kanak semasa saringan (contoh: pelekat/stiker lucu).
- Bakat membincangkan dalam kumpulan bagaimana mengurangkan masa menunggu semasa waktu puncak tanpa menjejaskan ketelitian saringan.

9. Rumusan

Stesen pemeriksaan yang direka dengan baik dari segi susunan, kelengkapan dan aliran masuk memastikan proses saringan fizikal berjalan lancar dan tidak menyebabkan kesesakan pada waktu puncak ketibaan, sambil kekal mesra dan tidak menakutkan bagi kanak-kanak kecil. Bilangan stesen perlu disesuaikan dengan saiz tadika — pengalaman Tadika Bestari menunjukkan satu stesen sahaja tidak mencukupi apabila bilangan murid

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka surat 13 / 31
---------	-----------------------------	--------------------

melebihi 40 orang.

Bab 4: Welcoming pupils and parents/guardian

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menerangkan tatacara menyambut kanak-kanak dan ibu bapa/penjaga.
- Mengaplikasikan komunikasi yang sesuai semasa ketibaan.
- Mengenal pasti kepentingan sambutan positif terhadap kesediaan emosi kanak-kanak untuk belajar.

1. Definisi dan Konsep Asas

Sambutan (*welcoming*) dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak merujuk kepada interaksi pertama guru dengan kanak-kanak dan penjaganya setiap pagi, yang berfungsi sebagai penentu nada emosi (*emotional tone*) bagi keseluruhan hari persekolahan. KSPK menegaskan perkembangan JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelktual, Sosial) secara holistik, dan domain Emosi/Sosial bermula seawal detik pertama kanak-kanak melangkah masuk — bukan hanya semasa sesi pembelajaran formal. Kajian dalam bidang psikologi kanak-kanak awal turut menunjukkan bahawa peralihan (*transition*) yang lancar dari penjagaan ibu bapa kepada guru mengurangkan tekanan (*separation anxiety*) dan meningkatkan kesediaan kanak-kanak untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran sepanjang hari.

2. Greeting Procedures

Guru menyambut setiap kanak-kanak dengan mesra (sapaan nama, senyuman, kontak mata sejajar tinggi kanak-kanak, bertutur pada aras fizikal yang sama dengan cara membongkok/berlutut) untuk membina rasa selamat dan positif sebelum sesi bermula. Amalan ini turut menyokong perkembangan JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelktual, Sosial) di bawah KSPK.

3. Proper Communication

Komunikasi ringkas dan mesra dengan ibu bapa/penjaga bagi bertukar maklumat penting (contoh: status kesihatan semalam, ubat yang perlu diberi, mood kanak-kanak pagi itu) — dijalankan tanpa menghalang aliran ketibaan kanak-kanak lain, biasanya dalam masa kurang seminit setiap keluarga.

4. Prosedur Langkah demi Langkah — Sambutan Ketibaan

Guru berdiri di titik sambutan tetap, kelihatan jelas kepada kanak-kanak dan ibu bapa yang datang.

Turun ke aras mata kanak-kanak (berlutut/membongkok) sebelum bercakap.

Sebut nama kanak-kanak dan berikan sapaan pilihan (lihat amalan Bab ini).

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 15/31
---------	-----------------------------	------------------

Tanya ibu bapa/penjaga soalan ringkas mengenai status kesihatan atau maklumat penting semalam.

Rekod maklumat penting (jika ada) dalam buku log ringkas sebelum kanak-kanak diteruskan ke stesen pemeriksaan.

Ucapkan selamat tinggal kepada ibu bapa/penjaga dan pastikan kanak-kanak selesa sebelum ibu bapa beredar.

Jika kanak-kanak menunjukkan tanda kesedihan berpanjangan, guru mengiringi kanak-kanak ke aktiviti peralihan (contoh: permainan meja) untuk mengalih perhatian secara positif.

5. Contoh Amalan Tadika

Sesetengah tadika mengamalkan "sapaan pilihan" di mana kanak-kanak memilih cara disambut (high-five, tabik hormat, lambaian, atau pelukan ringkas) untuk memupuk autonomi dan kesejahteraan emosi, mengurangkan tangisan perpisahan (separation anxiety) pada peringkat awal tahun persekolahan.

Jadual 7 — Jenis Maklumat yang Perlu Ditukar Semasa Sambutan

Kategori Maklumat	Contoh	Tindakan Guru
Kesihatan semalam	Demam ringan, tidak nyenyak tidur	Pantau lebih rapat sepanjang hari
Ubat perlu diberi	Ubat demam jam 10 pagi	Rekod dan tetapkan peringatan
Mood pagi	Kanak-kanak rewel/sedih	Sediakan aktiviti peralihan lembut
Perubahan rutin di rumah	Baru ada adik baharu	Beri perhatian emosi tambahan

Jadual 8 — Perbandingan Gaya Sambutan Mengikut Umur Kanak-Kanak

Peringkat Umur	Gaya Sambutan Sesuai	Sebab
4 tahun	Sapaan fizikal ringkas (high-five, lambaian)	Perkembangan bahasa terhad, respons visual/fizikal lebih berkesan
5 tahun	Sapaan verbal + fizikal (nama + high-five)	Mula memahami identiti diri dan nama
6 tahun	Sapaan verbal lebih panjang, soalan ringkas	Boleh berkomunikasi dua hala dengan lebih matang

Kajian Kes Tadika 1 — Tadika Ceria, 25 murid, 2 guru

Seorang kanak-kanak baharu di Tadika Ceria menangis setiap pagi semasa ibu bapanya beredar. Guru memperkenalkan "sapaan pilihan" dan membenarkan kanak-kanak tersebut memilih boneka kegemaran untuk dipegang semasa sambutan. Dalam tempoh dua minggu, tangisan berkurangan secara ketara kerana kanak-kanak mula mengaitkan ketibaan dengan sesuatu yang dia boleh kawal sendiri.

Kajian Kes Tadika 2 — Tadika Bestari, 40 murid, 4 guru

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 16/31
----------------	-----------------------------	------------------

Peringkat Umur	Gaya Sambutan Sesuai	Sebab
Tadika Bestari menghadapi cabaran menyambut 40 kanak-kanak dalam tempoh 30 minit tanpa menjejaskan kualiti komunikasi dengan ibu bapa. Penyelesaiannya: dua guru fokus sepenuhnya kepada sambutan sementara dua lagi menguruskan stesen pemeriksaan, membolehkan setiap keluarga tetap mendapat interaksi bermakna walaupun bilangan murid ramai.		

6. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

- Kesilapan:* Guru bercakap dengan ibu bapa sambil berdiri tegak, kanak-kanak berasa terpinggir daripada perbualan. *Cara mengelak:* Sentiasa turun ke paras mata kanak-kanak dahulu.
- Kesilapan:* Maklumat penting (ubat, alahan) disampaikan secara lisan sahaja dan terlupa. *Cara mengelak:* Rekod segera dalam buku log, jangan bergantung pada ingatan.
- Kesilapan:* Komunikasi dengan satu ibu bapa mengambil masa terlalu lama, menyebabkan barisan panjang. *Cara mengelak:* Had masa satu minit; perbualan lebih panjang dijadualkan semula (contoh: waktu jemputan petang).

7. Senarai Semak Ringkas (Sedia Difotokopi)

- ☐ Guru berada di titik sambutan sebelum pintu dibuka
- ☐ Sapaan dilakukan pada aras mata kanak-kanak
- ☐ Maklumat penting daripada ibu bapa direkod
- ☐ Kanak-kanak kelihatan selesa sebelum ibu bapa beredar
- ☐ Barisan/masa menunggu tidak melebihi had ditetapkan

8. Aktiviti Pengukuhan

- Bakat berlakon simulasi sambutan kanak-kanak baharu yang menangis, mengaplikasikan teknik sapaan pilihan.
- Bakat menyenaraikan lima soalan ringkas yang sesuai ditanya kepada ibu bapa dalam masa kurang seminit.
- Bakat membincangkan bagaimana menyesuaikan gaya sambutan mengikut peringkat umur (rujuk Jadual 8).

9. Rumusan

Sambutan yang mesra dan komunikasi ringkas dengan ibu bapa membina hubungan kepercayaan dan membantu peralihan kanak-kanak dari rumah ke prasekolah dengan lancar, sekali gus menetapkan nada positif untuk keseluruhan hari pembelajaran. Amalan seperti sapaan pilihan (Tadika Ceria) dan pengagihan tugas sambutan berasingan daripada

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka surat 17/31
----------------	-----------------------------	------------------

saringan (Tadika Bestari) membuktikan bahawa kualiti sambutan tidak perlu dikorbankan walaupun bilangan murid ramai.

Bab 5: Basic health screening procedures

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menerangkan dasar badan kawal selia berkaitan saringan kesihatan.
- Mengenal pasti dasar dan prosedur MoH bagi penyakit seperti Cacar Air dan HFMD.
- Menjalankan pemeriksaan fizikal asas menggunakan alat yang betul.
- Membezakan tindakan susulan bagi kes disyaki dan kes disahkan.

1. Definisi dan Konsep Asas

Saringan kesihatan asas (*basic health screening*) merujuk kepada pemeriksaan ringkas dan pantas (bukan diagnosis perubatan) yang dijalankan oleh guru bagi mengesan tanda-tanda awal penyakit berjangkit sebelum kanak-kanak bercampur dengan rakan sekelas. Ini adalah amalan pencegahan (*preventive*), bukan rawatan — guru tidak membuat diagnosis, tetapi membuat keputusan operasi (benar masuk / pantau / rujuk) berdasarkan tanda yang kelihatan. Kerangka undang-undang yang menyokong amalan ini termasuk Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988 (Act 342) yang mewajibkan pelaporan penyakit berjangkit tertentu, dan garis panduan operasi KKM/MOH bagi pusat jagaan dan pendidikan awal kanak-kanak.

2. Regulatory Bodies Policy

Merujuk Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988 (Pindaan 2021) yang mewajibkan institusi pendidikan awal kanak-kanak menjalankan saringan dan melaporkan kes penyakit berjangkit kepada Pejabat Kesihatan Daerah dalam tempoh yang ditetapkan.

3. MoH Policy & Procedures — Chicken Pox, HFMD

Kanak-kanak dengan tanda cacar air (ruam berlepuh berair) atau HFMD (Hand, Foot and Mouth Disease — luka mulut, ruam tangan/kaki, demam) perlu diasingkan serta-merta di ruang isolasi dan ibu bapa dihubungi mengikut prosedur MoH untuk pengambilan segera dan rujukan perubatan.

4. Prosedur Langkah demi Langkah — Saringan Kesihatan di Stesen

Guru memakai sarung tangan bersih untuk setiap kanak-kanak (atau sanitasi tangan antara setiap pemeriksaan).

Ukur suhu badan menggunakan termometer inframerah pada dahi, jarak mengikut arahan pengeluar alat.

Perhatikan wajah dan kulit kanak-kanak untuk ruam, kemerahan mata, atau tanda luar biasa.

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 19/2025-C01/NP(1/4)
---------	-----------------------------	--------------------------------

Tanya ibu bapa/penjaga (jika masih hadir) sebarang gejala yang diperhatikan di rumah.

Rekod bacaan suhu dan pemerhatian dalam borang/buku log.

Jika bacaan/tanda normal, kanak-kanak dibenarkan meneruskan ke proses handover (Bab 8).

Jika bacaan/tanda tidak normal, guru merujuk kepada Jadual 9 (Tindakan Susulan) dan mengasingkan kanak-kanak di ruang isolasi sementara ibu bapa dihubungi.

Semua kes disyaki/disahkan direkod berasingan untuk tujuan pelaporan kepada Pejabat Kesihatan Daerah jika perlu.

5. Common Disease Symptom dan Tools

Tanda umum: demam ($>37.5^{\circ}\text{C}$), batuk, ruam kulit, mata merah berair, hidung berair berterusan. Alat: termometer inframerah, senter kecil untuk memeriksa tekak/mulut, dan borang senarai semak simptom.

Jadual 9 — Tindakan Susulan Mengikut Status Kes

Status	Tindakan Segera	Siapa Dihubungi	Tempoh
Kes disyaki (tanda ringan)	Pantau, catat dalam log	Guru kelas dimaklumkan	Sepanjang hari
Kes disyaki (tanda jelas: demam tinggi, ruam)	Asingkan di ruang isolasi	Ibu bapa/penjaga	Serta-merta
Kes disahkan (cacar air/HFMD)	Asingkan segera, elak sentuhan rakan	Ibu bapa + rekod pelaporan	Serta-merta, ambil dalam 1 jam
Wabak (>2 kes serupa dalam kelas sama)	Laporkan kepada Pejabat Kesihatan Daerah	Pihak berkuasa kesihatan	Mengikut tempoh berkanun

Jadual 10 — Perbandingan Cacar Air vs HFMD

Ciri	Cacar Air (Chicken Pox)	HFMD
Tanda utama	Ruam berlepuh berair di seluruh badan	Luka mulut, ruam tangan/kaki
Demam	Biasa hadir	Biasa hadir
Tempoh isolasi disyorkan	Sehingga semua lepuh berkerak	Sehingga simptom hilang, ikut nasihat doktor
Kumpulan paling berisiko	Kanak-kanak belum divaksin	Kanak-kanak bawah 5 tahun

Kajian Kes Tadika 1 — Tadika Ceria, 25 murid, 2 guru

Seorang kanak-kanak tiba dengan suhu 37.8°C tetapi kelihatan aktif dan ceria seperti biasa. Guru bertugas mengikut Jadual 9 dan tetap mengasingkan kanak-kanak tersebut sementara ibu bapa dihubungi, walaupun tingkah laku kelihatan normal — prinsip "ikut bacaan alat, bukan tanggapan sendiri" dipegang teguh untuk mengelakkan kesilapan penilaian.

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka surat 20/31
---------	-----------------------------	------------------

Ciri	Cacar Air (Chicken Pox)	HFMD
Kajian Kes Tadika 2 — Tadika Bestari, 40 murid, 4 guru Tadika Bestari mengalami tiga kes HFMD dalam kelas yang sama dalam tempoh seminggu. Mengikut prosedur, pihak pengurusan melaporkan kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan menutup kelas berkenaan selama tempoh yang disyorkan MoH untuk pembersihan mendalam sebelum dibuka semula, mengelakkan penularan lebih luas kepada kelas lain.		

6. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

- Kesilapan: * Guru membenarkan kanak-kanak masuk kelas kerana "nampak sihat" walaupun bacaan suhu tinggi. *Cara mengelak: * Sentiasa patuh kepada bacaan alat dan Jadual 9, bukan pertimbangan visual semata-mata.
- Kesilapan: * Termometer tidak dikalibrasi/bateri lemah menyebabkan bacaan tidak tepat. *Cara mengelak: * Semak bateri dan fungsi alat setiap pagi sebelum digunakan.
- Kesilapan: * Kes disyaki tidak direkod kerana dianggap "kes kecil". *Cara mengelak: * Semua kes, walau seringan mana, direkod untuk mengesan corak wabak.

7. Senarai Semak Ringkas (Sedia Difotokopi)

- ☐ Termometer berfungsi dan bateri mencukupi
- ☐ Sarung tangan/sanitasi tangan digunakan antara setiap kanak-kanak
- ☐ Setiap kanak-kanak diperiksa suhu dan tanda fizikal
- ☐ Kes disyaki/disahkan direkod dan tindakan mengikut Jadual 9
- ☐ Ruang isolasi sedia digunakan jika diperlukan

8. Aktiviti Pengukuhan

- Bakat mensimulasikan proses saringan penuh ke atas rakan sekelas menggunakan termometer replika, merekod dapatan dalam borang.
- Bakat membezakan tiga senario kes (demam ringan, ruam jelas, batuk tanpa demam) dan menentukan tindakan susulan yang betul mengikut Jadual 9.
- Bakat menghafal dan menerangkan semula peruntukan pelaporan di bawah Act 342 dalam kata-kata sendiri.

9. Rumusan

Pemeriksaan kesihatan asas yang berpandukan dasar MoH dan badan kawal selia membolehkan pengesanan awal penyakit berjangkit dan melindungi kesihatan seluruh kelas daripada wabak. Kepatuhan ketat kepada bacaan alat dan prosedur bertulis — bukan tanggapan peribadi — adalah prinsip yang dipegang oleh Tadika Ceria dan terbukti penting dalam kes wabak sebenar di Tadika Bestari.

Bab 6: Types of record procedure

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan jenis-jenis kaedah merekod hasil pemeriksaan fizikal.
- Memilih kaedah rekod yang sesuai mengikut keperluan prasekolah.
- Menjelaskan kepentingan kerahsiaan rekod kesihatan kanak-kanak.

1. Definisi dan Konsep Asas

Rekod (*record*) dalam konteks saringan ketibaan merujuk kepada dokumentasi bertulis atau digital bagi setiap keputusan dan pemerhatian yang dibuat semasa pemeriksaan fizikal — ia berfungsi sebagai bukti kepatuhan SOP, alat pengesanan trend kesihatan, dan rujukan sekiranya berlaku pertikaian atau pertanyaan ibu bapa. Prinsip kerahsiaan maklumat kanak-kanak turut selari dengan semangat Akta Kanak-Kanak 2001 yang menekankan kepentingan terbaik kanak-kanak (*best interest of the child*) termasuk perlindungan maklumat peribadi dan kesihatan daripada pendedahan tidak wajar.

2. Checklist

Borang bercetak ringkas menandakan "Lulus/Tidak Lulus" bagi setiap item pemeriksaan — cepat digunakan pada waktu puncak dan mudah disemak oleh pengetua pada penghujung hari.

3. Logbook

Buku log manual merekod suhu, masa tiba, dan pemerhatian bagi setiap kanak-kanak — berguna sebagai rekod sejarah jangka panjang dan bukti sokongan sekiranya berlaku pertanyaan ibu bapa kemudian.

4. Digital Form

Aplikasi/borang atas talian yang membolehkan rekod dicapai segera oleh pentadbir dan ibu bapa, serta memudahkan penjaan laporan automatik dan trend kesihatan mingguan/bulanan.

5. Prosedur Langkah demi Langkah — Mengisi dan Menyimpan Rekod

Selepas saringan, guru mengisi checklist/logbook/borang digital dengan segera (bukan diingat untuk diisi kemudian).

Pastikan nama kanak-kanak, masa tiba, bacaan suhu, dan status (lulus/pantau/rujuk) diisi lengkap.

Jika kes disyaki/disahkan, tambah catatan terperinci dan tindakan yang diambil.

Rekod harian disemak dan ditandatangani oleh penyelia/pengetua pada penghujung hari.

Rekod fizikal disimpan dalam fail berkunci; rekod digital dilindungi kata laluan dan capaian terhad.

Rekod disimpan mengikut tempoh yang ditetapkan pihak pengurusan (contoh: minimum satu tahun akademik) sebelum diarkibkan.

Sebarang permintaan akses rekod oleh pihak ketiga (selain ibu bapa kanak-kanak berkenaan) perlu kebenaran bertulis pengetua.

6. Kerahsiaan Rekod

Rekod kesihatan tergolong maklumat sensitif dan hanya boleh diakses oleh kakitangan berkaitan, selaras prinsip menjaga maruah dan privasi kanak-kanak.

Jadual 11 — Perbandingan Checklist vs Logbook vs Digital Form

Kriteria	Checklist	Logbook	Digital Form
Kelajuan pengisian	Sangat pantas	Sederhana	Pantas (jika stabil)
Kemudahan capaian sejarah	Rendah	Sederhana	Tinggi
Risiko kehilangan fizikal	Tinggi (kertas boleh hilang)	Sederhana	Rendah (backup awan)
Kos permulaan	Rendah	Rendah	Sederhana–tinggi
Sesuai untuk	Tadika kecil, waktu puncak	Rekod jangka panjang	Tadika besar, laporan automatik

Jadual 12 — Senarai Semak Kandungan Wajib Setiap Rekod

Medan	Wajib Diisi	Contoh
Nama kanak-kanak	Ya	Kanak-Kanak A
Masa tiba	Ya	7.45 pagi
Bacaan suhu	Ya	36.8°C
Status pemeriksaan	Ya	Lulus / Pantau / Rujuk
Catatan tambahan	Jika berkaitan	Batuk ringan, dipantau
Tandatangan guru	Ya	Inisial guru bertugas

Kajian Kes Tadika 1 — Tadika Ceria, 25 murid, 2 guru

Tadika Ceria pada asalnya hanya menggunakan checklist ringkas tanpa catatan terperinci. Apabila seorang ibu bapa mempersoalkan mengapa anaknya tidak dihubungi walaupun demam pada siang hari, pihak tadika tidak mempunyai rekod terperinci untuk disemak. Selepas insiden ini, mereka beralih kepada gabungan checklist (untuk kelajuan pagi) dan logbook (untuk catatan terperinci sepanjang hari).

Kajian Kes Tadika 2 — Tadika Bestari, 40 murid, 4 guru

Tadika Bestari mengguna pakai borang digital yang membolehkan ibu bapa menyemak status saringan anak masing-masing secara langsung melalui aplikasi telefon, mengurangkan panggilan telefon berulang ke pejabat tadika dan meningkatkan ketelusan

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 23/31
---------	-----------------------------	------------------

Kriteria	Checklist	Logbook	Digital Form
operasi.			

7. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

- Kesilapan: * Rekod diisi lewat (selepas beberapa jam), menyebabkan maklumat tidak tepat. *Cara mengelak: * Isi serta-merta selepas setiap pemeriksaan, bukan secara kelompok kemudian.
- Kesilapan: * Rekod digital tidak mempunyai sandaran (*backup*) kertas semasa gangguan sistem. *Cara mengelak: * Sediakan borang kertas kecemasan sentiasa tersedia.
- Kesilapan: * Fail rekod dibiarkan terbuka/tidak berkunci di kaunter yang boleh dilihat orang ramai. *Cara mengelak: * Simpan dalam fail berkunci atau sistem digital berkata laluan.

8. Senarai Semak Ringkas (Sedia Difotokopi)

- ☐ Rekod diisi serta-merta selepas pemeriksaan
- ☐ Semua medan wajib (Jadual 12) lengkap
- ☐ Rekod disemak dan ditandatangani penyelia pada penghujung hari
- ☐ Rekod disimpan berkunci/berkata laluan
- ☐ Sandaran kertas sedia jika sistem digital gagal

9. Aktiviti Pengukuhan

- Bakat mereka bentuk satu borang checklist ringkas yang boleh digunakan dalam masa kurang 30 saat setiap kanak-kanak.
- Bakat membincangkan kebaikan dan keburukan sistem digital berbanding kertas dalam konteks tadika kecil vs besar.
- Bakat menulis satu dasar kerahsiaan ringkas (2–3 ayat) yang sesuai dipamerkan di pejabat tadika.

10. Rumusan

Pemilihan kaedah rekod — kertas atau digital — perlu memastikan maklumat kesihatan setiap kanak-kanak boleh dijejak, disimpan secara sulit, dan dirujuk semula dengan tepat bila diperlukan. Pengalaman Tadika Ceria menunjukkan bahawa rekod yang tidak lengkap boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa, manakala Tadika Bestari membuktikan sistem digital yang telus mengurangkan beban komunikasi pentadbiran.

Bab 7: Pupil health condition

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyatakan julat suhu badan normal kanak-kanak prasekolah.
- Mengenal pasti tanda dan simptom yang menunjukkan kanak-kanak tidak sihat.
- Membuat keputusan sama ada kanak-kanak selamat diteruskan ke kelas.

1. Definisi dan Konsep Asas

Keadaan kesihatan kanak-kanak (*pupil health condition*) merujuk kepada penilaian ringkas guru terhadap status fisiologi dan tingkah laku kanak-kanak semasa ketibaan, bagi menentukan sama ada kanak-kanak selamat mengikuti aktiviti bersama rakan sekelas. Penilaian ini bergantung kepada dua sumber utama: bacaan objektif (suhu badan) dan pemerhatian subjektif berasaskan pengetahuan guru terhadap tingkah laku biasa kanak-kanak tersebut — kombinasi kedua-dua sumber ini penting kerana bacaan alat sahaja tidak mencukupi untuk mengesan semua jenis ketidaksihatan.

2. Normal Temperature

Suhu badan normal kanak-kanak prasekolah adalah antara 36.1°C hingga 37.5°C apabila diukur menggunakan termometer inframerah di dahi; bacaan perlu diulang jika kanak-kanak baru sahaja bersenam atau berada di bawah cahaya matahari.

3. Sign and Symptoms

Tanda tidak sihat: Suhu badan melebihi 37.5°C, batuk berterusan, ruam kulit, mata merah berair (atau mata berair kemerahan), atau kelesuan luar biasa berbanding tingkah laku biasa kanak-kanak tersebut. Guru yang mengenali setiap kanak-kanak dapat mengesan perubahan tingkah laku dengan lebih pantas berbanding petugas baharu.

4. Prosedur Langkah demi Langkah — Menilai Keadaan Kesihatan dan Membuat Keputusan

Ukur suhu badan menggunakan termometer inframerah mengikut prosedur Bab 5.

Bandingkan bacaan dengan julat normal 36.1°C–37.5°C.

Perhatikan tanda fizikal tambahan: batuk berterusan, ruam kulit, mata merah berair.

Bandingkan tingkah laku semasa dengan tingkah laku biasa kanak-kanak tersebut (aktif/riang berbanding lesu/murung).

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 25/8
---------	-----------------------------	-----------------

Jika suhu badan melebihi 37.5°C ATAU terdapat sekurang-kurangnya satu tanda tambahan yang jelas, klasifikasikan sebagai "tidak selamat diteruskan ke kelas".

Jika normal pada semua aspek, benarkan kanak-kanak meneruskan ke proses handover (Bab 8).

Rekod keputusan dan asas keputusan dalam borang (rujuk Bab 6).

Jika ragu-ragu, sentiasa pilih pendekatan berhati-hati (pantau/asingkan) berbanding membenarkan masuk kelas.

5. Contoh Amalan Tadika

Sesetengah tadika menggunakan carta warna (hijau/kuning/merah) pada borang pemeriksaan untuk memudahkan guru bertugas membuat keputusan pantas sama ada kanak-kanak "selamat masuk kelas", "pantau lanjut", atau "hubungi ibu bapa segera".

Jadual 13 — Carta Warna Keputusan Kesihatan

Warna	Kriteria	Tindakan
Hijau	Suhu normal, tiada tanda tambahan, tingkah laku biasa	Selamat masuk kelas
Kuning	Suhu sempadan (37.3°C–37.5°C) atau satu tanda ringan	Pantau lanjut sepanjang jam pertama
Merah	Suhu melebihi 37.5°C atau tanda jelas (ruam, mata merah, kelesuan luar biasa)	Hubungi ibu bapa segera, asingkan

Jadual 14 — Senarai Tanda Tidak Sihat dan Tindakan Berkaitan

Tanda	Tahap Kebimbangan	Tindakan Segera
Suhu badan melebihi 37.5°C	Tinggi	Asingkan, hubungi ibu bapa
Batuk berterusan	Sederhana–Tinggi	Pantau, sediakan tisu, elak sentuhan rapat
Ruam kulit	Sederhana–Tinggi	Asingkan sehingga punca disahkan
Mata merah berair	Sederhana	Pantau, elak kongsi alat/tuala
Kelesuan luar biasa berbanding tingkah laku biasa	Sederhana–Tinggi	Pantau rapi, rujuk jika berterusan

Kajian Kes Tadika 1 — Tadika Ceria, 25 murid, 2 guru

Seorang kanak-kanak di Tadika Ceria yang biasanya sangat aktif tiba dalam keadaan senyap dan enggan bermain, walaupun suhu badan normal pada bacaan pertama. Guru yang mengenali tingkah laku biasa kanak-kanak tersebut mengesyaki kelesuan luar biasa berbanding tingkah laku biasa dan memilih untuk memantau lebih rapi — didapati kanak-kanak tersebut demam tinggi tiga jam kemudian. Kes ini menunjukkan kepentingan mengenali setiap kanak-kanak secara individu, bukan bergantung semata-mata kepada bacaan alat.

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka surat 26/31
---------	-----------------------------	------------------

Tanda	Tahap Kebimbangan	Tindakan Segera
Kajian Kes Tadika 2 — Tadika Bestari, 40 murid, 4 guru Dengan bilangan murid yang ramai, Tadika Bestari kurang mengenali setiap kanak-kanak secara mendalam berbanding tadika kecil. Untuk mengatasi ini, mereka meminta ibu bapa mengisi nota ringkas "tingkah laku biasa anak saya" pada permulaan tahun, yang disimpan bersama rekod kanak-kanak dan dirujuk oleh guru bertugas sekiranya berlaku keraguan.		

6. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

- Kesilapan:* Guru hanya bergantung kepada bacaan suhu dan mengabaikan tanda tingkah laku. *Cara mengelak:* Sentiasa nilai kedua-dua aspek — bacaan objektif dan pemerhatian tingkah laku.
- Kesilapan:* Guru baharu yang tidak mengenali kanak-kanak membuat keputusan tanpa merujuk rekod/maklumat ibu bapa. *Cara mengelak:* Sediakan nota ringkas tingkah laku biasa setiap kanak-kanak (seperti amalan Tadika Bestari).
- Kesilapan:* Keputusan "kuning" (pantau) tidak dipantau secara aktif selepas keputusan awal dibuat. *Cara mengelak:* Tetapkan semakan susulan pada selang masa tertentu (contoh: setiap jam).

7. Senarai Semak Ringkas (Sedia Difotokopi)

- ☐ Suhu badan diukur dan dibandingkan dengan julat normal (36.1°C–37.5°C)
- ☐ Tanda tambahan diperhatikan: batuk berterusan, ruam kulit, mata merah berair
- ☐ Tingkah laku dibandingkan dengan tingkah laku biasa kanak-kanak
- ☐ Keputusan (hijau/kuning/merah) direkod dengan asas yang jelas
- ☐ Kes kuning/merah dipantau/tindakan susulan dijadualkan

8. Aktiviti Pengukuhan

- Bakat menilai lima senario kanak-kanak (dengan pelbagai kombinasi suhu dan tanda) dan mengklasifikasikan setiap satu mengikut carta warna Jadual 13.
- Bakat menerangkan mengapa "kelesuan luar biasa berbanding tingkah laku biasa" adalah tanda yang sukar dikesan oleh guru baharu, dan cara mengatasinya.
- Bakat mereka bentuk templat nota ringkas "tingkah laku biasa anak saya" untuk diisi ibu bapa pada awal tahun.

9. Rumusan

Pengetahuan tentang julat suhu normal dan tanda-tanda tidak sihat membolehkan guru membuat keputusan pantas sama ada kanak-kanak selamat diteruskan ke kelas atau perlu diasingkan bagi melindungi kesihatan kanak-kanak lain. Kes di Tadika Ceria membuktikan bahawa mengenali tingkah laku biasa setiap kanak-kanak boleh mengesan tanda awal

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka surat 27 / 31
----------------	-----------------------------	--------------------

penyakit sebelum bacaan suhu menunjukkan sebarang keabnormalan.

Bab 8: Pupil's handover

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menerangkan proses penyerahan kanak-kanak kepada guru kelas.
- Menggunakan senarai kelas dengan betul semasa serah tugas.
- Mengenal pasti maklumat yang wajib disampaikan semasa handover.

1. Definisi dan Konsep Asas

Handover* atau serah tugas merujuk kepada peralihan tanggungjawab penjagaan kanak-kanak daripada guru di stesen pemeriksaan kepada guru kelas, merangkumi pemindahan fizikal (kanak-kanak dihantar ke kelas yang betul) dan pemindahan maklumat (status kesihatan, arahan khas, kehadiran). Ini adalah titik kritikal terakhir dalam rantai ketibaan — kegagalan pada peringkat ini boleh menyebabkan kanak-kanak "hilang" dalam sistem kehadiran atau maklumat kesihatan penting tercicir sebelum sampai kepada guru yang akan bertanggungjawab sepanjang hari.

2. Classroom Listing

Senarai nama kanak-kanak mengikut kelas disemak untuk memastikan setiap kanak-kanak dihantar ke kelas yang betul dan kehadiran direkodkan pada masa yang sama, mengelakkan sebarang kanak-kanak "hilang" dalam sistem kehadiran.

3. Handover Procedures

Guru di stesen pemeriksaan menyerahkan kanak-kanak secara lisan dan bertulis (nota kesihatan jika ada, contoh: "ubat demam perlu diberi jam 10 pagi") kepada guru kelas, memastikan maklumat penting tidak tercicir antara dua peringkat rutin.

4. Prosedur Langkah demi Langkah — Proses Handover Penuh

Guru stesen menyemak nama kanak-kanak pada Classroom Listing dan mengesahkan kelas yang betul.

Guru stesen mengiringi atau mengarahkan kanak-kanak ke kelas berkenaan (bergantung susun atur premis).

Guru stesen menyampaikan maklumat lisan ringkas kepada guru kelas (status kesihatan, mood, arahan khas).

Jika terdapat nota bertulis (ubat, alahan, susulan), nota diserahkan secara fizikal kepada guru kelas — bukan disebut sahaja.

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 29/31
---------	-----------------------------	------------------

Guru kelas menandakan kehadiran kanak-kanak pada senarai kelas serta-merta.

Guru kelas mengesahkan penerimaan maklumat (contoh: mengganggu/menandatangani ringkas pada nota) sebagai bukti serah terima.

Sebarang percanggahan (kanak-kanak tiada dalam senarai, maklumat tidak lengkap) dilaporkan segera kepada penyelia sebelum aktiviti kelas bermula.

Selepas semua kanak-kanak diserahkan, guru stesen menyerahkan salinan rekod harian (Bab 6) kepada pejabat/penyelia.

5. Contoh Amalan Tadika

Sesetengah tadika menggunakan "kad handover" kecil berwarna yang disematkan pada baju kanak-kanak jika terdapat arahan khas (ubat, alahan, susulan kesihatan), membolehkan guru kelas menyemak sekali pandang tanpa perlu merujuk semula rekod bertulis penuh.

Jadual 15 — Peranan Semasa Proses Handover

Peranan	Tanggungjawab	Titik Serah
Guru Stesen	Sahkan kelas, sampaikan maklumat lisan/bertulis	Menghantar kanak-kanak
Guru Kelas	Terima kanak-kanak, tanda kehadiran, sahkan maklumat	Menerima kanak-kanak
Penyelia/Pengetua	Selesaikan percanggahan, terima rekod harian	Selepas semua handover selesai

Jadual 16 — Senarai Maklumat Wajib Semasa Handover

Maklumat	Wajib/Pilihan	Cara Penyampaian
Nama dan kelas kanak-kanak	Wajib	Lisan + Classroom Listing
Status kesihatan (hijau/kuning/merah)	Wajib	Lisan + rekod bertulis
Ubat yang perlu diberi	Wajib jika berkaitan	Nota bertulis/kad handover
Alahan makanan/ubat	Wajib jika berkaitan	Kad handover, dipamerkan jelas
Mood/tingkah laku pagi	Digalakkan	Lisan ringkas

Kajian Kes Tadika 1 — Tadika Ceria, 25 murid, 2 guru

Pada suatu hari, guru stesen di Tadika Ceria lupa menyampaikan maklumat bahawa seorang kanak-kanak perlu diberi ubat alahan pada jam 10 pagi kerana maklumat hanya disampaikan secara lisan tergesa-gesa. Selepas insiden ini (ubat tertinggal diberi), tadika mewajibkan semua arahan ubat/alahan direkod dalam kad handover bertulis, bukan lisan semata-mata, tanpa pengecualian.

Kajian Kes Tadika 2 — Tadika Bestari, 40 murid, 4 guru

Tadika Bestari menggunakan sistem kad handover berwarna (merah untuk alahan, kuning untuk ubat, hijau untuk tiada arahan khas) yang disematkan pada baju setiap kanak-kanak semasa proses handover. Guru kelas boleh menyemak status setiap kanak-kanak "sekali pandang" tanpa perlu membaca rekod penuh setiap kali, mempercepatkan proses walaupun

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 29/30
---------	-----------------------------	------------------

Maklumat	Wajib/Pilihan	Cara Penyampaian
dengan bilangan murid yang ramai.		

6. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

- Kesilapan: * Maklumat penting disampaikan secara lisan sahaja dan terlupa oleh guru kelas yang sibuk. * Cara mengelak: * Sentiasa sertakan nota/kad bertulis untuk arahan kritikal (ubat, alahan).
- Kesilapan: * Kanak-kanak dibiarkan berjalan sendiri ke kelas tanpa pengiringan, berisiko tersesat. * Cara mengelak: * Guru stesen atau pembantu mengiringi kanak-kanak sehingga sampai ke pintu kelas.
- Kesilapan: * Kehadiran tidak ditanda serta-merta, menyebabkan kekeliruan jika berlaku kecemasan (siapa sebenarnya hadir). * Cara mengelak: * Tandakan kehadiran sebaik sahaja kanak-kanak sampai di kelas, bukan kemudian.

7. Senarai Semak Ringkas (Sedia Difotokopi)

- ☐ Classroom Listing disemak dan kelas disahkan betul
- ☐ Maklumat lisan disampaikan kepada guru kelas
- ☐ Nota/kad bertulis diserahkan untuk arahan khas (ubat/alahan)
- ☐ Kehadiran ditanda serta-merta oleh guru kelas
- ☐ Percanggahan dilaporkan kepada penyelia sebelum kelas bermula

8. Aktiviti Pengukuhan

- Bakat mensimulasikan proses handover penuh bagi tiga kanak-kanak (satu normal, satu perlu ubat, satu ada alahan) menggunakan kad handover.
- Bakat mereka bentuk templat kad handover berwarna yang ringkas dan mudah difahami sekali pandang.
- Bakat membincangkan apa yang perlu dilakukan jika seorang kanak-kanak didapati TIDAK berada dalam Classroom Listing semasa handover.

9. Rumusan

Proses serah tugas yang teratur, disokong senarai kelas yang tepat dan komunikasi bertulis, memastikan tiada kanak-kanak tercicir atau salah kelas sebelum aktiviti pembelajaran bermula. Pengalaman Tadika Ceria menunjukkan risiko sebenar komunikasi lisan semata-mata, manakala sistem kad handover berwarna Tadika Bestari membuktikan penyelesaian praktikal yang boleh diguna pakai walaupun bilangan murid ramai.

SOALAN:

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 31 / 31
----------------	-----------------------------	--------------------

Mengapakah social learning theory penting dalam membentuk tingkah laku selamat kanak-kanak semasa ketibaan?

Jawapan model: Kerana kanak-kanak belajar melalui pemerhatian dan peniruan tingkah laku guru; apabila guru sentiasa menunjukkan tingkah laku berhati-hati dan teratur — seperti memeriksa kawasan permainan sebelum digunakan, berjalan (bukan berlari) di lorong, dan memegang pagar semasa menuruni tangga — kanak-kanak turut meniru dan membentuk kebiasaan selamat secara tidak langsung. Konsistensi guru dalam menunjukkan tingkah laku ini, bukan sekali-sekala, adalah kunci keberkesanan modelling menurut Bandura.

Nyatakan dua tanda yang membolehkan guru mengenal pasti kanak-kanak berkemungkinan menghidap HFMD semasa saringan kesihatan ketibaan.

Jawapan model: Luka/ulser di dalam mulut dan ruam pada tangan atau kaki, disertai demam — mengikut dasar MoH. Guru yang mengesan kombinasi tanda ini perlu mengasingkan kanak-kanak serta-merta di ruang isolasi dan menghubungi ibu bapa untuk pengambilan segera serta rujukan perubatan, selari prosedur MoH bagi Chicken Pox dan HFMD.

Apakah tujuan utama proses handover kepada guru kelas selepas pemeriksaan fizikal?

Jawapan model: Untuk memastikan setiap kanak-kanak diserahkan ke kelas yang betul (disahkan melalui Classroom Listing) dan maklumat kesihatan/pemerhatian penting — termasuk arahan ubat atau alahan — dimaklumkan secara lisan dan bertulis kepada guru kelas, mengelakkan sebarang kecaciran maklumat yang boleh menjejaskan keselamatan kanak-kanak sepanjang hari persekolahan.

RUJUKAN: